

OTRAS DERMATOPATÍAS

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Normas Hospital Garrahan 2002

Dermatitis del área del pañal

Es una afección que compromete el área del pañal, en respuesta a diferentes agentes etiológicos.

Etiopatogenia

La causa primaria de la irritación es la acción de enzimas proteolíticas (proteasas y lipasas) de las heces, la cual se ve favorecida por la humidificación producida por la orina y las modificaciones de pH urinario.

Factores de riesgo

Cambio infrecuente de pañales (exceso de humedad más oclusión).

Mala higiene.

Terreno predisponente (en especial en seborreicos y atópicos).

Lavado excesivo de la zona.

Edad (menores de 2 años)

1) Dermatitis irritativa

Eritema que habitualmente se localiza en áreas convexas de periné, zona inferior del abdomen y cara interna de muslos, con respeto de los pliegues. La variante *papuloerosiva* se presenta como pústulas de erosión rápida que, por la oclusión y el roce, evolucionan a pápulas relativamente grandes (1 a 1,5 cm de diámetro) erosionadas, en las superficies convexas. Se observa en lactantes mayores y en niños con incontinencia urinaria o fecal.

2) Dermatitis candidiasica

Se caracteriza por presentar eritema rojo intenso de bordes bien delimitados, con escamas blanquecinas, además de pequeñas vesicopústulas aisladas que rodean a la lesión principal y que se extienden hacia el abdomen inferior, raíz de muslos y glúteos (lesiones satélites). A diferencia de la dermatitis irritativa, los pliegues están comprometidos, ya que suele comenzar en la región perianal. Debe sospecharse sobreinfección por *C. Albicans* en toda dermatitis del área del pañal **con más de 72 horas de evolución** (abalado por el curso de “Dermatología” 2016 de la EducaSAP).

3) Dermatitis atópica

Es la dermatitis del área del pañal en pacientes atópicos; se caracteriza por intensa inflamación, exudación y marcado prurito, con compromiso de los pliegues.

4) Dermatitis seborreica

El diagnóstico puede hacerse a través del reconocimiento de una lesión grasosa, color salmón, con escamas amarillentas en su superficie. Tiene especial predilección por los pliegues, y coincide con el compromiso del cuero cabelludo y otras áreas intertriginosas.

Diagnósticos diferenciales

Deben hacerse con otras patologías que comprometen el área del pañal: psoriasis, histiocitosis, acrodermatitis enteropática, sífilis, granuloma glúteo infantil y dermatitis perianal (por *Estreptococo* grupo A, *Salmonella*, *Estafilococo aureus*, *Pseudomona aeruginosa*).

Tratamiento

1. Los cambios frecuentes del pañal especialmente cuando los niños presentan diarreas acuosas y el uso de pañales superabsorbentes fundamentalmente durante la noche son medidas fundamentales de prevención. No es aconsejable el uso de las toallitas descartables, que habitualmente tienen perfume sino el oleo calcáreo con un algodón, ya que pueden inducir dermatitis irritativas de contacto.
2. Sustancias aislantes como la Pasta Lassar u otras con óxido de Zinc. No son convenientes los preparados que contengan ácido bórico y bicarbonato de sodio que pueden ser absorbidos en forma percutánea y ser tóxicos para el niño. ("Macoderm": Zinc + Bismuto – "Hipoglós": Zinc + Bismuto + Ac. Bórico)
3. Descongestivas como la Pasta al agua si hay exudación.
4. En algunos casos severos puede llegar a ser necesaria la utilización de corticoides no fluorados para disminuir la inflamación. Éstos deben ser siempre de baja potencia, como la hidrocortisona al 1% o desonide y, en lo posible, sin ocluir inmediatamente, para disminuir la absorción.
5. Pastas con agregado de antimicóticos si se presume la presencia de Cándida ("Deralbine": Miconazol + óxido de Zinc).

Dermatitis seborreica

Es una dermatosis caracterizada por lesiones eritematosas, bien delimitadas, cubiertas por escamas amarillentas de aspecto grasiento y distribuidas en zonas que poseen una elevada concentración de glándulas sebáceas (cuero cabelludo, parte central de la cara, tercio superior de tronco y áreas intertriginosas).

Etiología

Aunque se han realizado numerosos intentos para relacionarla con infecciones (*Candida albicans*, *Pityrosporum ovale*), la causa de la dermatitis seborreica es todavía desconocida. La influencia de factores genéticos no es despreciable.

Presentación:

- **Costra láctea**

Comienza a las 3 ó 4 semanas de vida, como un eritema localizado en cuero cabelludo y cubierto de escamas adherentes, costras blanquecinas o amarillentas, untuosas, que aglutinan los cabellos. En ocasiones, el eritema y las escamas pueden extenderse a cara, tronco, zona del pañal y pliegues, con grados variables de intensidad.

- **Dermatitis del area del pañal**

El eritema es liso, brillante; se ubica en la convexidad glútea y toma los pliegues genitocrurales. A diferencia de las dermatitis por contacto simples, suele haber lesiones aisladas por fuera del área cubierta por los pañales, y es frecuente la asociación con lesiones en el cuero cabelludo.

- **Eritrodermia seborreica**

Es la generalización de una dermatitis seborreica del lactante en un niño por lo demás sano.

Diagnósticos diferenciales

Dermatitis atópica, tiña capitis, dermatitis irritativa del pañal, dermatitis moniliásica del pañal, histiocitosis, acrodermatitis enteropática y psoriasis.

Tratamiento

La costra láctea puede extraerse mediante un masaje suave **con aceite de almendras o de cocina** antes del lavado con un champú suave. Pueden utilizarse aceite mineral ictiolado al 5%, champús queratolíticos a base de coaltar, azufre o ácido salicílico (en niños mayores).

En el cuerpo, usar vaselinas sólidas o cremas humectantes. Si el eritema es muy importante puede usarse un corticoide tópico de baja potencia pocos días (hidrocortisona 1%), a veces combinado también con un antimicótico tópico. En zonas de intertrigo, es conveniente utilizar antimicóticos asociados. La involución espontánea se alcanza alrededor de los 8 a 9 meses de vida, al agotarse la influencia de las hormonas maternas.

Prurigo simple agudo (estrofulo)

Dermatosis pruriginosa producida por sensibilización adquirida a las picaduras de insectos (mosquitos; pulgas de los perros, gatos y pájaros; chinches).

Examen Físico

Prurito intenso.

Pápulas de 3 a 10 mm de diámetro, con una vesícula en su superficie que, por acción del rascado, devienen rápidamente en una costra serosa (seropápula).

Si el proceso se cronifica por brotes repetidos, se produce liquenificación de las lesiones por acción del rascado.

Las lesiones se agrupan preferentemente en miembros superiores, inferiores, cintura abdominal y cara, y pueden comprometer otras zonas.

Diagnósticos diferenciales

Se deben considerar los siguientes: sarna, varicela, urticaria, acrodermatitis papulosa infantil, acropustulosis, prurigo actínico, prurigo por frío y prurigo nodular.

Tratamiento

1. Antihistamínicos por vía oral.
2. Lociones con difenhidramina + Calamina ("Caladryl")
3. Pasta al agua, con o sin el agregado de mentol.
4. Tratamiento, si es necesario, del el impétigo.

Pitiriasis versicolor

Es la infección crónica del estrato córneo cutáneo causada por el hongo *Malassezia Furfur* y la mayoría de las veces es asintomática. Tiene distribución universal, pero es más prevalente en climas tropicales y subtropicales. Afecta principalmente a adultos jóvenes y pospúberes. Pero puede además afectar a menores de 6 meses, dado que presentan también una secreción sebácea importante.



Clínica

Las lesiones en general se hacen evidentes en verano y se distribuyen en sitios con gran número de glándulas sebáceas: tronco y miembros superiores, aunque en ocasiones afecta cara y cuello. Consisten en máculas múltiples de color variable (blanco, castaño claro, rosadas) cubiertas por una fina descamación que se pone en evidencia al raspar su superficie "signo de la uñada". Si bien se trata de máculas pequeñas - menores de 1 cm de diámetro- múltiples, pueden coalescer formando

grandes placas de bordes policíclicos. Son asintomáticas, aunque a veces presentan un leve prurito.

Diagnóstico

Generalmente es clínico. A la inspección con Luz de Wood muestran fluorescencia verde-amarillenta. El examen micológico directo con hidróxido de potasio muestra levaduras agrupadas

Tratamiento

Muchas veces es una infección recurrente que requiere tratamiento de mantenimiento tópico o sistémico.

- **Tópico:** Antimicóticos imidazólicos ("Micolis 1%": Econazol) en crema o aerosol 2 veces por día por 4 semanas, adicionarse champú con sulfuro de selenio al 2.5%, cinc piritiona o ketoconazol 2%.

- **Sistémico:** itraconazol 5 mg/kg/día por 7 días. Sugiriendo el ejercicio físico luego de la ingesta para favorecer la liberación de estos a través del sudor. Se recomienda este modo terapéutico en casos de pitiriasis extendida o resistente a los tratamientos tópicos.

Tiñas

Tinea capitis

La tiña de cuero cabelludo es la invasión del tallo del pelo por un dermatofito, y es la más común en los niños. El agente causal más frecuente en nuestro país es el ***Microsporum canis***; más raros son el *Microsporum gypseum* y el *Trichophyton violaceum*; el *Trichophyton schoenleinii* es excepcional.

Clasificación

A) **Inflamatoria:** Querion de Celso. Es una tumoración inflamatoria dolorosa, habitualmente única, en casquete de esfera; es blanda al tacto y, al hacer presión, elimina pus por los orificios foliculares. Los cabellos son expulsados con facilidad; con frecuencia se forma una costra gruesa con pelos adheridos entre sí. Suele acompañarse de linfadenopatías occipitales. La supuración es producida por fenómenos de hipersensibilidad, aunque no debe descartarse la presencia de un co-patógeno bacteriano.

B) **No inflamatoria**

- **T. Microspórica:** determina la aparición de pocas placas (entre 1 y 2), de 4 a 5 cm de diámetro. Todos los pelos de la placa son ralos, cortados a 3 ó 4 mm de su salida, despulidos, y se desprenden con facilidad. La superficie del cuero cabelludo está cubierta de escamas finas, de color grisáceo.

- **T. Tricofítica:** se caracteriza por la aparición de múltiples placas, de pocos mm de diámetro. Se alternan pelos sanos con pelos afectados; estos últimos se encuentran doblados en forma de M o Z, no emergen de la superficie y dan el aspecto de puntos negros. El cuero cabelludo es descamativo.

Factores de riesgo - Hacinamiento o una higiene deficiente. - Desnutrición. - Bajo nivel socioeconómico. - Guarderías. - Traumatismos.

Diagnóstico

Se confirma con el examen micológico directo y cultivo. La muestra se tomará del borde de la lesión, macerando las escamas con hidróxido de potasio. La observación de los pelos afectados suele permitir la diferencia entre *Microsporum* (ectotrix) y *Trichophyton* (endotrix). El cultivo se realizará cada mes, hasta su negativización.

Diagnósticos diferenciales

Se debe realizar con: dermatitis seborreica, eccematides, psoriasis, alopecia areata, tricotilomanía, foliculitis decalvans, impétigo y lupus eritematoso.

Tratamiento

No inflamatoria: se utilizan **champúes queratolíticos**, que pueden ser alternados con Ketoconazol.

En todos los casos debe emplearse tratamiento oral. La droga de elección sigue siendo la **Griseofulvina**, 15-20 mg/kg/día una vez al día, con alimento graso, durante 2 a 3 meses, dependiendo de la negativización del cultivo; posteriormente, se aconseja tomarlo 20 días más.

En pacientes con trastornos hepáticos o con resistencia a la griseofulvina (hecho cada día más frecuente), se utilizará **Terbinafina** (la cual también debe usarse con precaución en estos casos) 10 mg/kg/día una vez al día VO durante 4 semanas.

Querion de celso: se trata con fomentos de **Agua blanca de Códex**. Si hay un copatógeno bacteriano, administrar el antibiótico correspondiente. Se usa también **Griseofulvina**.

Tinea corporis

Es una infección fúngica de la piel lampiña, cuyas manifestaciones clínicas se producen como resultado de la invasión y la proliferación de los hongos en la capa córnea de la epidermis. En nuestro medio, el más frecuente es el **Microsporum canis**; puede ser transmitido por animales infectados (gatos, perros). El *Trichophyton rubrum* puede ser adquirido por contacto directo con otros sujetos infectados.



En general, presentan lesiones inflamatorias, de forma policíclica, de crecimiento excéntrico, y cuya máxima actividad se sitúa en los bordes de la lesión. Estas presentan eritema, pápulas, microvesículas, escamas, con menor frecuencia pústulas y costras. La zona central presenta un color pardo y es ligeramente escamosa. Casi siempre hay prurito. La localización habitual es en las zonas expuestas del cuerpo. A veces acompañan a las tiñas del cuero cabelludo. Se denomina tinea incógnita a la tinea sobre la que se aplicaron corticoides tópicos, lo que conduce a la disminución o ausencia de escamas y a la modificación de las características clínicas típicas.

Diagnósticos diferenciales

Se realiza con: pitiriasis rosada, eccematide acromiante (pitiriasis alba), eccema numular, psoriasis, dermatitis por contacto, dermatitis seborreica, tiña versicolor y lupus eritematoso.

Tratamiento

Imidazólicos("Micolis 1%": Econazol) o alilaminas locales (cremas) en una o dos aplicaciones diarias.

En caso de tinea corporis muy extendida o refractaria al tratamiento tópico, tiña incógnita, tinea profunda (análogo del querion de Celso en la piel) se requiere tratamiento sistémico. Entre ellos se puede utilizar griseofulvina, terbinafina, itraconazol y fluconazol.

Molusco contagioso

Es una enfermedad viral común y benigna de la piel y las membranas mucosas que por lo general afecta a los niños. En los adultos puede ser transmitida por vía sexual. Es causado por el virus del molusco contagioso, que es un POXVIRUS (ADN), de gran tamaño.

Período de incubación

Es variable, de 14 días a 6 meses. Son pápulas de color blanco perladas, lisas y brillantes cupuliformes, que muestran una umbilicación central característica y una base ligeramente eritematosa. Por debajo de la zona de umbilicación existe un material central similar a la leche cuajada que puede exprimirse con facilidad. Usualmente son pequeñas, de 3-7 mm de diámetro, pero en algunos casos pueden alcanzar varios centímetros de diámetro. Pueden ser únicas o múltiples, aisladas o formando placas en forma agminada y en algunos casos diseminadas.

Localización: cara (predominantemente párpados), cuello, tronco, axilas, genitales y mucosas. En general son asintomáticas, pero pueden ocasionar prurito.

Epidemiología

Es raro antes del año de vida, el pico de incidencia mayor es entre 1-4 años. Los varones se afectan con más frecuencia. Se observan más comúnmente en niños con dermatitis atópica, terapias inmunosupresoras, sida y sarcoidosis; lo cual sugiere que la inmunidad celular es significativa en el control y eliminación de la infección. Se transmite por: contacto directo, por vía sexual (más frecuente en adultos) y por intermedio de objetos contaminados (piscinas, baños públicos, toallas, etc).

Diagnosticos diferenciales

Verrugas vulgares, acné, varicela, hiperplasias sebáceas, papilomas, piodermitis, granuloma piógeno y liquen plano.

Tratamiento

1. Destrucción de las lesiones con una cureta dérmica previa anestesia local con lidocaína al 2,5 % en parches oclusivos.
2. Aplicación de cremas de **peróxido de benzoilo** al 5% o **ácido retinoico** al 0,05% , en las lesiones una vez por día.
3. En los cuadros que están sobreinfectados se debe realizar primero tratamiento con antisépticos y antibióticos locales.

Evolución

La duración es impredecible, algunas lesiones involucionan espontáneamente dentro de los 6 a 9 meses, mientras que otras persisten 3-4 años. Resuelven espontáneamente sin dejar cicatriz. Es frecuente la recidiva.

Complicaciones

- Infección bacteriana secundaria.
- Reacción eccematosa alrededor de las lesiones.
- Conjuntivitis, queratitis (cuando se encuentran alrededor de los párpados).